



ROTASI RODA PANTAU TENSI

Panduan Praktis Ibu Hamil Pesisir
Mencegah Preeklamsia dan Anak Stunting



Tim Pengusul Riset Hibah BIMA 2026: Serli, Sitti Mawaddah Umar, Rasdiana R
Didanai oleh: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Riset hibrid ROTASI menghadirkan inovasi pemantauan mandiri status tekanan darah melalui integrasi alat Hibrid ROTASI (ROda panTAu tenSI). Inisiatif ini merupakan wujud nyata kontribusi dalam menyukseskan SDG's 3.2, yaitu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah pada tahun 2030. Booklet ini juga sejalan dengan Asta Cita 4 untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan, serta sains dan teknologi. Semoga booklet ini dapat menjadi panduan praktis yang bermanfaat bagi ibu hamil dan tenaga kesehatan dalam mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Makassar,
Tim Riset ROTASI



DAFTAR ISI



Angka & Fakta: Mengapa Anda Harus Peduli?



Mengenal: Hipertensi, Preeklamsia, Eklamsia, dan Stunting



Hubungan Preeklamsia dan Stunting



Bagaimana mencegah Preeklamsia



Bagaimana cara menggunakan Hibrid ROTASI (Alat Fisik & Aplikasi Android)



Diet DASH ibu hamil



Manajemen Stres Ibu Hamil, Pascapersalinan & Depresi Postpartum



Penatalaksanaan Pascapersalinan & Risiko Penyakit Jangka Panjang



Lembar Catatan Harian Pemantauan Mandiri ROTASI



Hubungi jika keadaan darurat!

ANGKA & FAKTA MENGAPA ANDA HARUS PEDULI?

'Silent Killer'



23%
KEMATIAN
IBU



RISIKO PREEKLAMPSIA



Stroke

**Risiko
18x Lipat**

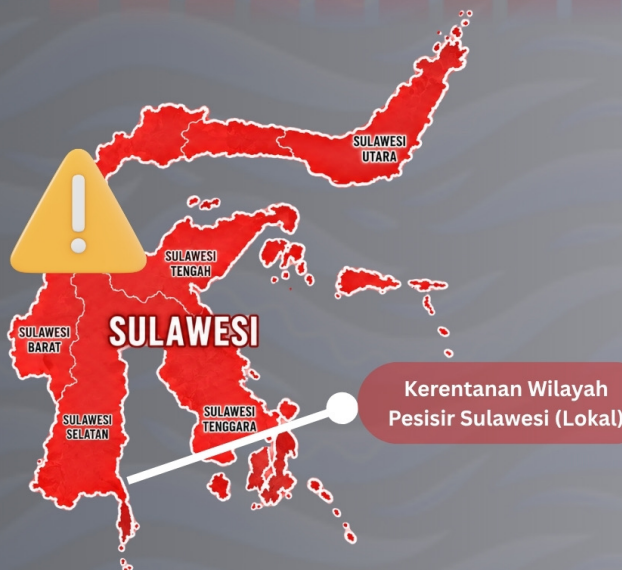
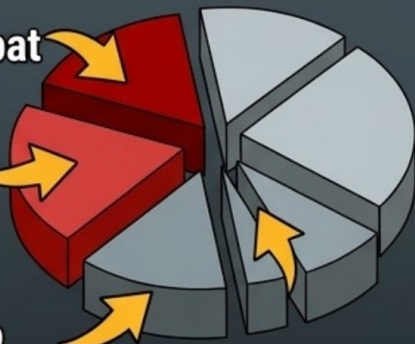


Sindrom
**Risiko
2.8x Lipat**



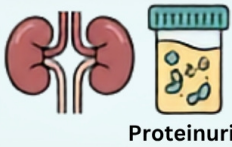
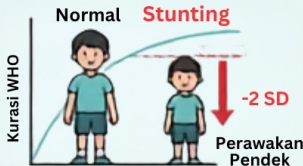
Masuk ICU

**Risiko
2.8x Lipat**



AKI Terbanyak (4,7%) & Kematian Neonatal Tertinggi (7,7%) Akibat Preeklamsia di Indonesia. Kejang Persalinan Mencapai 11,4% karena Lambatnya Deteksi Dini di Pesisir. **(Data INAPRES 2025/2026)**

MENGENAL HIPERTENSI, PREEKLAMPSIA, EKLAMPSIA, DAN STUNTING

Hipertensi Kehamilan		TDS $\geq$ 140 mmHg dan/atau TDD $\geq$ 90 mmHg yang baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu
Preeklamsia	 Proteinuria	Hipertensi setelah 20 minggu disertai kebocoran protein urine (proteinuria) atau disfungsi organ target maternal (seperti sakit kepala hebat, mata kabur, sesak napas)
Eklamsia	 Kegawatan Darurat	Kegawatan darurat akut berupa kejang-kejang umum tonik-klonik pada penderita preeklamsia.
Stunting	 Kurasi WHO	Kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis atau hipoksia sejak dalam rahim (tinggi badan < -2 SD kurva pertumbuhan WHO)

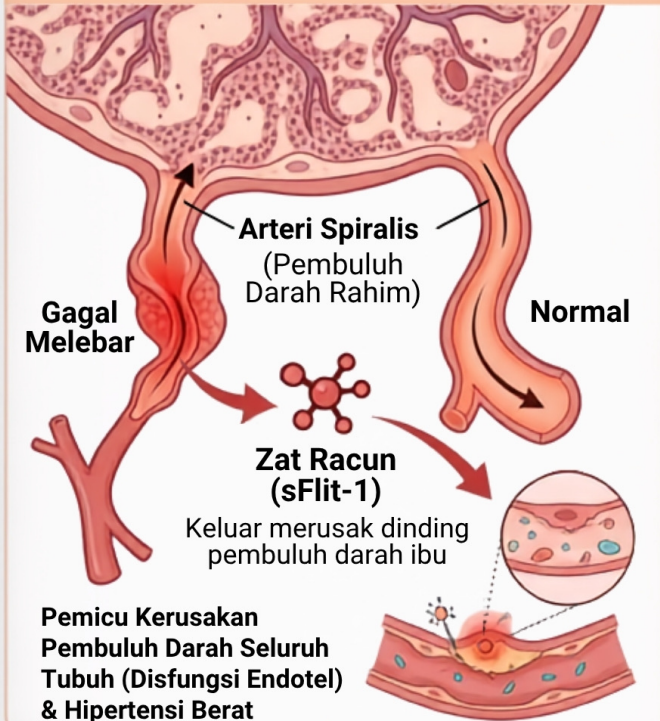
UPDATE InaSH 2025: Diagnosis Preeklamsia kini TIDAK WAJIB ada protein urine, cukup Tensi Tinggi + Gangguan Organ!

Pembaruan Klinis

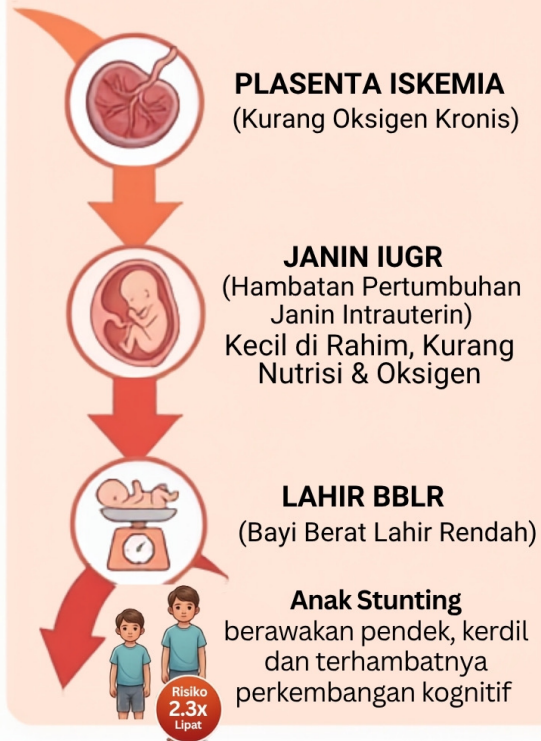
Proteinuria tidak lagi menjadi parameter mutlak untuk menegaskan diagnosis preeklamsia; adanya hipertensi baru disertai disfungsi organ lain sudah cukup untuk menegaskan diagnosis.

HUBUNGAN Preeklamsia dan Stunting

PROSES SEBAB (Maladaptasi Plasenta)

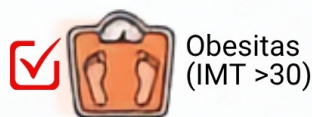
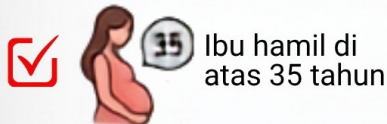


PROSES AKIBAT (Hubungan ke Stunting)



VISUAL PENAPISAN (Checklist Faktor Risiko NICE & KIA 2024)

Identifikasi Faktor Risiko Anda:



WASPADA! Adanya salah satu faktor ini, periksa tekanan darah lebih sering!

Referral: Ibu wajib segera dirujuk ke faskes sekunder jika memiliki 1 Risiko Tinggi atau 2 Risiko Sedang.

BAGAIMANA MENCEGAH PREEKLAMPSIA

Batasi garam, zat pemicu & Detoksifikasi Gaya Hidup



Sodium

Sodium <300 mg/day

- Membatasi asupan sodium, kafein (<300 mg/hari)
- Menghentikan total konsumsi alkohol, merokok, obat-obatan tanpa resep dokter, serta paparan zat kimia berbahaya karena berdampak langsung pada janin.

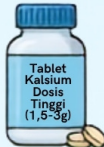
Manajemen Berat Badan (BMI Ideal) & Konsumsi Asam Folat Sejak Dini



BMI normal
(18.5–24.9 kg/m²)

- Targetkan IMT normal (18,5–24,9 kg/m²) sebelum hamil.
- Obesitas maupun berat badan kurang di masa prakonsepsi meningkatkan risiko diabetes gestasional, preeklamsia, dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Kecukupan Zat Besi, Kalsium, & Vitamin D & Aktivitas Fisik



- Konsumsi Asam Folat Sejak Dini
- Asupan protein tinggi, zat besi untuk mencegah anemia dan kalsium untuk pembentukan tulang janin dan mencegah preeklamsia

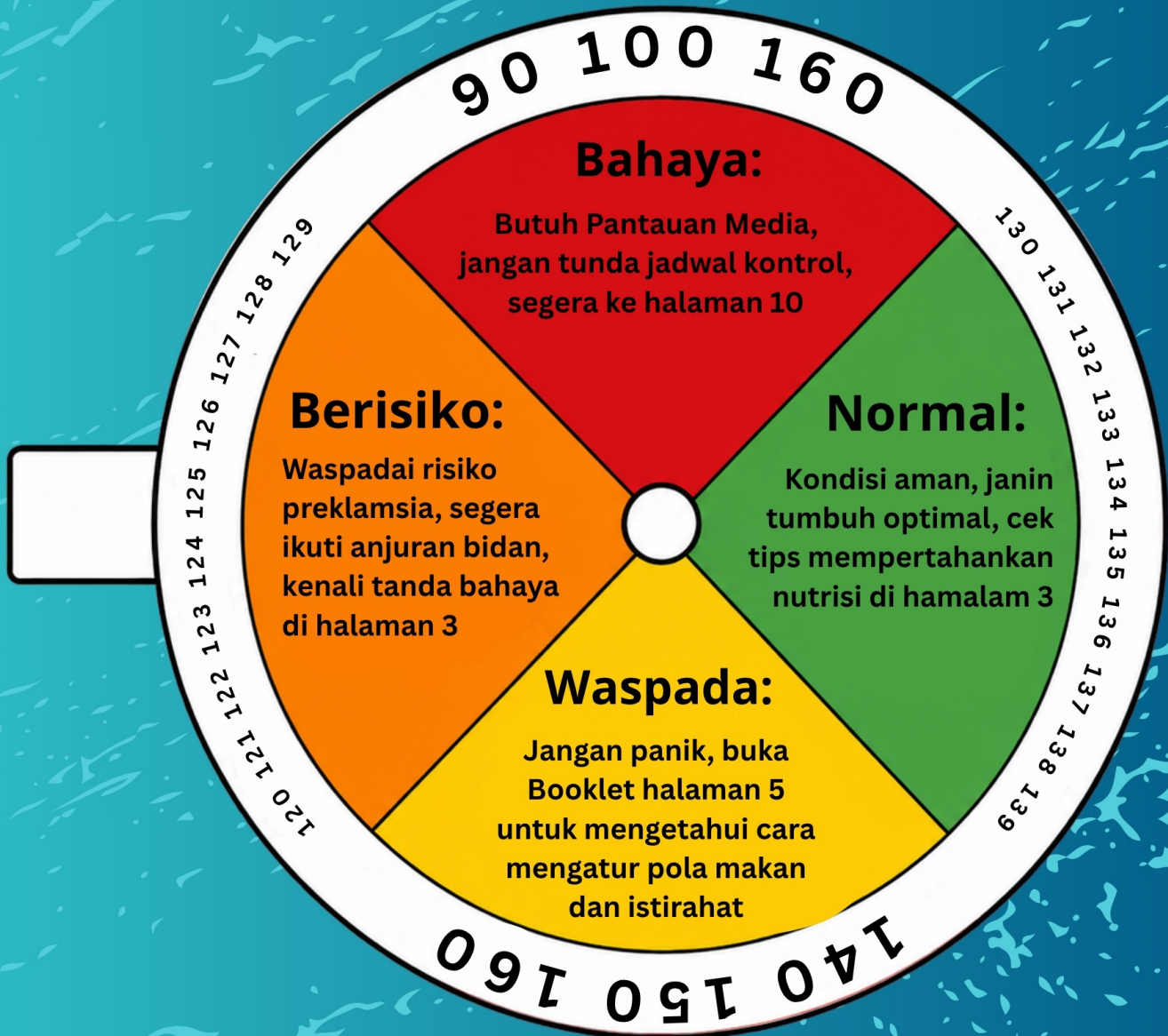
WARNING BOX

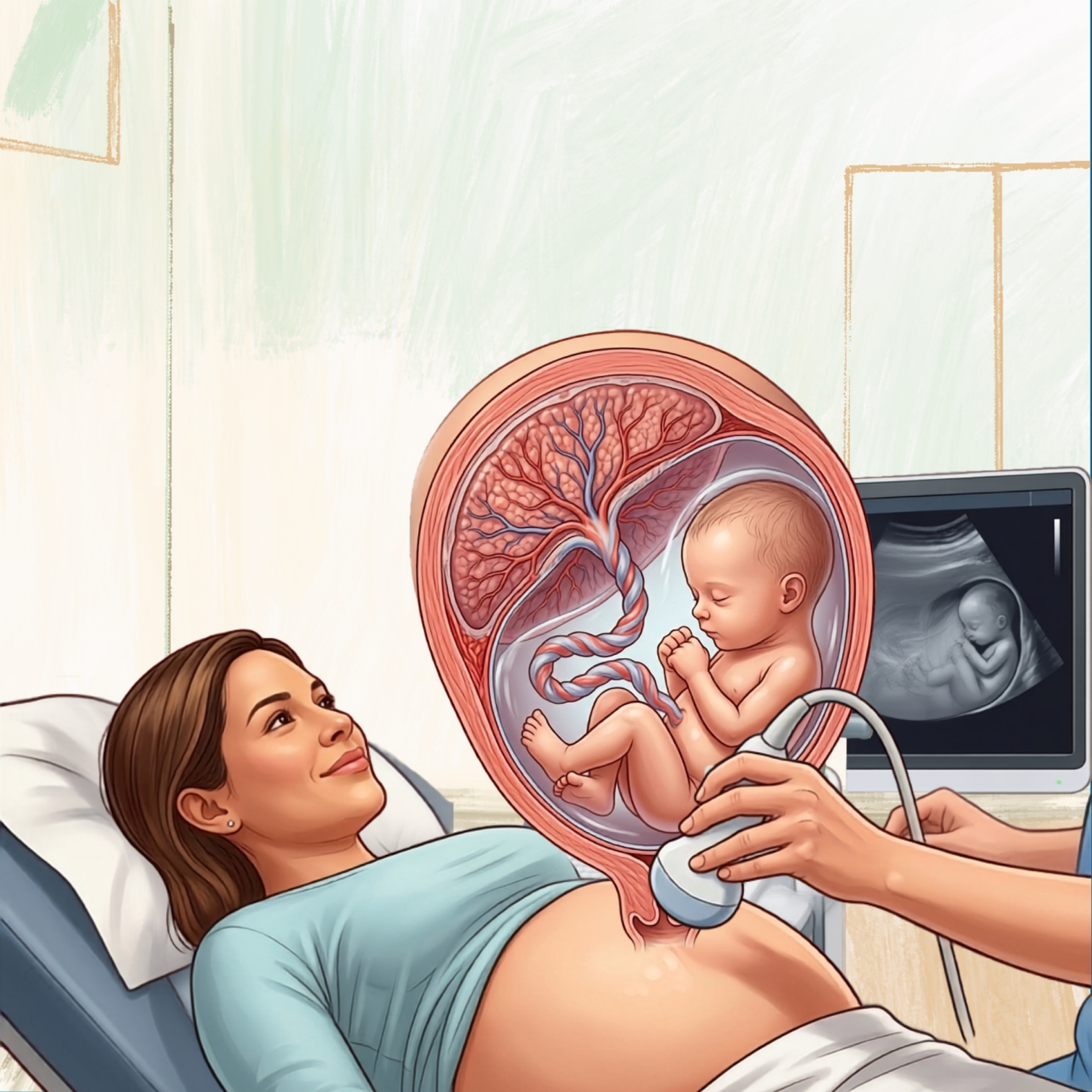


DILARANG KERAS!

Mengonsumsi obat tanpa resep dokter karena dapat berbahaya bagi ibu dan janin

CARA MENGGUNAKAN ROTASI





Diet DASH Ibu Hamil



TIDAK TEPAT

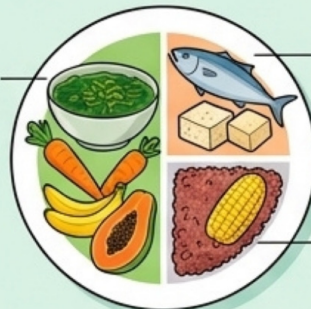
Isi Piringku

TEPAT (Diet DASH)



Tinggi Garam (Natrium), Lemak Jenuh, Gula, dan Bahan Pengawet.

1/2 Porsi: Sayuran (daun Kelor, Wortel) & Buah (Pisang, Pepaya)



Tinggi Serat, Kalium, Kalsium. Rendah Garam/Santan

STOP



Ikan Asin, Kecap, Makanan Kaleng (Tinggi Natrium)

> 1 sendok teh garam per hari

GO



Pisang, Pepaya, Sayuran Hijau (Tinggi Kalium)



Kapurung (Sup Sagu Ikan)



Gado-gado



Daun Sayur Kelor



Palumara (yellow th soup di asam jawa)

Pangan Lokal (Kearifan Lokal) Tinggi Nutrisi

Ikan Banyara / Katombo / Kembung, Kaya Omega-3



Kacang Hijau/Kedelai



Telur Rebus



Yoghurt Rendah Lemak



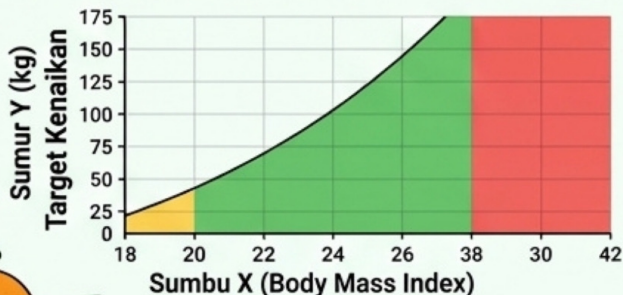
Jagung Rebus



Buah Potong



Kacang Hijau Rebus



Ibu Kurus (IMT < 18.5)



Target Kenaikan: 12.5-18 kg



Ibu Obesitas (IMT > 30)

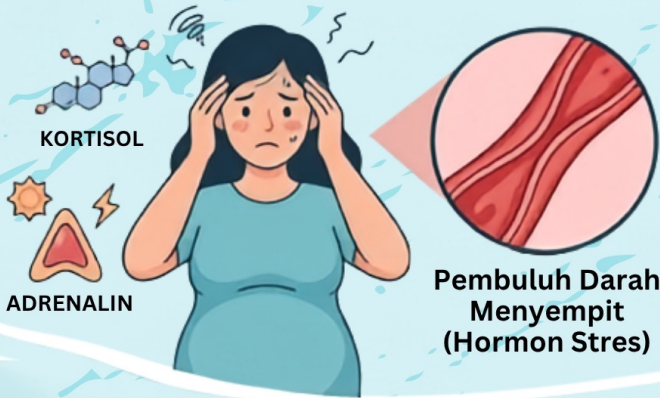


Target Kenaikan Ketat 5-9 kg

MANAJEMEN STRES IBU HAMIL, PASCAPERSALINAN & DEPRESI POSTPARTUM

Sebab Fisiologis Stres

Stres emosional mengaktifkan sistem saraf simpatik, melepaskan hormon kortisol dan adrenalin harian. Hormon ini menyempitkan pembuluh darah secara mendadak, jantung bekerja lebih keras, keras, dan melambungkan tekanan darah.



Teknik Relaksasi Napas Lambat (Slow Breathing)

Latih pernapasan lambat dipandu stopwatch atau asisten aplikasi ROTASI harian: Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang napas perlahan 6 detik. Lakukan 15 menit setiap hari harian. Terbukti menurunkan Sistolik 5–10 mmHg.



Dukungan Suami & Pola Asuh Bebas Stunting

Terapkan pola asuh yang sehat: *Co-parenting* & Asuh Responsif-Hangat (Merangsang oksitosin anak, mempercepat pencernaan, menyerap nutrisi optimal, mencegah *stunting* secara psikososial).



PENATALAKSANAAN PASCAPERSALINAN & RISIKO PENYAKIT JANGKA PANJANG

Masa Nifas yang Kritis
(Critical Postpartum Period)



Peringatan
>60%
Kematian
Terjadi
Disini!



Jadwal Pemantauan Tensi Pascapersalinan Serial
(Serial Postpartum BP Monitoring Schedule)



Peringatan Risiko Jangka Panjang
Ibu Eks-Preeklamsia (AHA 2025)



- Risiko Gagal Jantung & Hipertensi Menetap **Naik 4x!**
- Risiko Jantung Koroner & Stroke **Naik 2x!**
- Risiko Penyakit Ginjal Kronik (PGK) **Naik 4.7x!**
- Risiko Gagal Ginjal Akhir

MENYAMBUT SANG BUAH HATI

PERIODE EMAS 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN



Kesiapan Kegawatan di RS
(Hipertensi Berat SBP ≥ 160
atau DBP ≥ 110 mmHg)



Standar Emas
Cegah Kejang
Eklamsia ($>50\%$)

MgSO₄
(Magnesium Sulfat)



Kortikosteroid
(Antenatal)

Kematangan Paru Janin (<34
minggu). Mencegah RDS &
Kematian Bayi Baru Lahir

Profilaksis MgSO₄ wajib diberikan di faskes untuk mencegah kejang eklamsia.
Kortikosteroid jika persalinan dini (<34 minggu) diperlukan demi keselamatan ibu,
untuk mempercepat kematangan paru janin.

Pemantauan Kesejahteraan Janin Mandiri di Rumah



Hitung Gerakan Janin Aktif.
Minimal 3 kali gerakan dalam
30 menit!

Lakukan pemantauan harian. Pastikan janin bergerak aktif minimal 3 kali dalam 30 menit. Kurangnya gerakan menunjukkan Hipoksia (kurang oksigen) akibat sirkulasi plasenta buruk.

MENYAMPUT SANG BUAH HATI

PERIODE EMAS 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN



Selamat! Ibu sedang berada di masa emas pertumbuhan anak. Tujuan utama Ibu adalah memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, memiliki daya tahan kuat, dan berpartisipasi dalam Pencegahan Stunting.

TAHAP 1: Masa Kehamilan (270 Hari Dalam Kandungan)

Kunci pencegahan *Stunting* dimulai dari sini. Kesehatan Ibu adalah kesehatan janin.

Mencegah Preeklamsia (Hipertensi dalam Kehamilan)



- Mencegah preeklamsia
- Memastikan janin tumbuh sehat dengan nutrisi cukup
- Mendukung pencegahan Stunting
- Konsultasikan obat dengan dokter
- Pahami efek samping obat pada kehamilan
- Disiplin minum vitamin sesuai anjuran

Menjaga Janin Tetap Ternutrisi dengan Baik



- Pemeriksaan kehamilan rutin
- Cukupi istirahat dan kelola stres



- Hindari:**
- Rokok
 - Kafein Berlebih
 - Alkohol

TAHAP 2: Setahun Pertama Setelah Persalinan (Masa Bayi)

Masa adaptasi dan pertumbuhan fisik yang sangat pesat.

Pola Asuh Gizi



Pola Asuh Tumbuh Kembang & Kesehatan



TAHAP 3: Tahun Kedua (Masa Anak 1-2 Tahun)

Anak mulai mandiri, aktif, dan perkembangan bahasanya meningkat tajam.

Pola Asuh Gizi



Pola Asuh Tumbuh Kembang & Kesehatan



Ingat Bu, kegagalan pemenuhan gizi dan pengasuhan yang salah pada 1000 HPK berakibat **PERMANEN**. Dengan panduan di atas, Ibu sedang memberikan **HADIAH TERBAIK** untuk kehidupan anak.

Hubungi jika keadaan darurat!



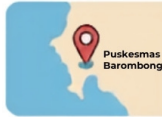
Ambulance Makassar

Call Center Darurat:
112



**Bidan Puskesmas
Barombong**

Kontak Bidan Lusi:
0812-2708-8315



**KAPAN HARUS SEGERA KE
BIDAN PUSKESMAS/FASKES?**

Ibu **wajib segera pergi** ke Puskesmas atau faskes terdekat
dalam **waktu 24 jam** jika:

1. ☐



Roda ROTASI warna
Oranye/Merah.
Konsisten harian.

2. ☐



Minimal 1 Tanda Bahaya
(Sakit Kepala Hebat, Mata Kabur,
Nyeri Ulu Hati, Sesak Napas).

3. ☐



Gerakan Janin Kurang Aktif
(<3 gerakan dalam 30 menit
pengamatan tenang).

**“Kenali warna tekanan darahmu,
lindungi dirimu dan bayimu”**

Pencegahan Stunting dari Hulu Kehamilan Pesisir

